内科含诊断 COPD ★★★（0~3 题）

- 并发症
  - 慢性肺心病 —— 缺氧致肺动脉高压（P_2 亢进）、右心功能不全（双下肢水肿等）
  - 自发性气胸（2013） —— 突发胸痛、继之呼吸困难、鼓音、呼吸音减弱或消失；首选 X 线
  - 呼吸衰竭
- 缺氧和 CO_2 潴留的机制（2023）
  - 阻塞性通气障碍：肺泡通气量↓（主要，2010、2016、2017） —— 多为Ⅱ型呼衰（$PaO_2 < 60$、$PaCO_2 > 50$）
  - 换气障碍 —— VA/Q 失调为主：↓（动静脉短路）和↑（肺泡无效腔增大）；弥散障碍 /DLCO ↓（仅导致缺氧） —— 可为Ⅰ型呼衰“有血气看血气”
  - 内源性 PEEP

通气功能障碍		
	阻塞性	限制性
常见疾病（2022）	COPD、支气管哮喘、支扩、细支气管炎	间质性肺病（特发性肺纤维化等）、胸膜病变、ARDS
特点（2013）	气流流速下降为主（FEV_1、FEV_1/FVC、MMFR ↓）	肺容积下降为主（RV、TLC、FVC ↓）
RV/TLC	明显↑（> 40% 为肺气肿）	正常或略↑